

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE REGULACIÓN EMOCIONAL COGNITIVA (CERQ)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación de 9 Estrategias Cognitivas de Afrontamiento ante el Estrés

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Regulación Emocional Cognitiva (CERQ - 36 ítems).
Nombre Original (Inglés)	<i>Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ)</i>
Autores Originales	Dras. Nadia Garnefski, Vivian Kraaij y Philip Spinhoven (2001, 2002), Leiden University.
Adaptaciones Españolas	Domínguez-Sánchez, Lasa-Aristu, Amor y Holgado-Tello (2011, 2013); Chamizo-Nieto et al.
Eje Clínico y Clasificación	Eje II: Procesos Psicológicos. Modelo Cognitivo de Regulación Emocional (Garnefski & Kraaij).
Tipo de Instrumento	Autoinforme dimensional de 36 reactivos con escala Likert de 5 puntos (1 a 5).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (desde los 12 años). Aplicable en clínica ambulatoria e investigación.
Tiempo de Administración	6 a 10 minutos en autoadministración; 12 minutos asistido.
Régimen de Licencia	Instrumento científico abierto de libre distribución para uso clínico y académico.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO COGNITIVO DEL CERQ

El CERQ fue desarrollado para aislar específicamente las estrategias **estrictamente cognitivas** (los pensamientos conscientes que una persona tiene durante o después de vivir un acontecimiento amenazante o estresante), distinguiéndolas de las estrategias conductuales de afrontamiento (ej. salir a correr, beber alcohol, buscar compañía).

Neurobiológicamente, el instrumento evalúa el funcionamiento diferencial de las redes prefrontales de control voluntario: mientras las estrategias adaptativas (reevaluación positiva, replanificación, perspectiva) reclutan activamente la corteza prefrontal dorsolateral y ventrolateral para modular a la baja la reactividad amigdalina, las estrategias desadaptativas (catastrofización, rumiación, autculpa-bilización) mantienen encendido el circuito límbico y el eje de estrés HPA mediante pensamientos perseverativos autorreferenciales mediados por la Red por Defecto (DMN).

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Estrategia Cognitiva	Ítems (4 c/u)	Rango Dir.	Operacionalización Clínica y Contenido del Pensamiento
1. Aceptación	2, 11, 20, 29	4 a 20	Pensamientos de aceptación y resignación madura ante la realidad inmodificable.
2. Focalización Positiva	4, 13, 22, 31	4 a 20	Pensar en temas placenteros o alegres en lugar de pensar en el evento negativo.
3. Replanificación	5, 14, 23, 32	4 a 20	Pensar en los pasos y acciones concretas para solucionar o manejar el problema.
4. Reevaluación Positiva	6, 15, 24, 33	4 a 20	Pensar en los aprendizajes o significados constructivos que deja la vivencia adversa.
5. Poner en Perspectiva	7, 16, 25, 34	4 a 20	Relativizar la gravedad comparándola con acontecimientos peores o su impacto temporal.
6. Autoculpabilización	1, 10, 19, 28	4 a 20	Pensamientos que atribuyen la culpa y la responsabilidad del fracaso exclusivamente a uno mismo.
7. Rumiación	3, 12, 21, 30	4 a 20	Focalización mental perseverativa y continua en el malestar y en el estresor.
8. Catastrofización	8, 17, 26, 35	4 a 20	Pensamientos que enfatizan de forma extrema el terror y la gravedad de lo sucedido.
9. Culpar a los Demás	9, 18, 27, 36	4 a 20	Pensamientos de hostilidad que sitúan toda la culpa del malestar en terceras personas.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente precisión en España: coeficientes alfa de Cronbach oscilan entre 0.77 y 0.90 en las 9 subescalas (Domínguez-Sánchez et al., 2011), destacando Catastrofización (0.87), Rumiación (0.84) y Reevaluación Positiva (0.85).
Estructura Nonafactorial	El AFC valida de forma sobresaliente el modelo de 9 factores específicos (CFI = 0.95, RMSEA = 0.046), demostrando que las 9 dimensiones no se solapan y representan constructos cognitivos diferenciados.
Estabilidad Temporal	Buena estabilidad test-retest ($r = 0.68$ a 0.79 a los 3 meses), mostrando que las personas poseen estilos habituales cognitivos estables de afrontamiento ante estresores.
Validez Concurrente y Predictiva	Catastrofización y Rumiación predicen varianza única masiva en depresión (PHQ-9, $r = 0.60$) y ansiedad clínica (GAD-7, $r = 0.58$). Reevaluación Positiva predice bienestar y autoeficacia general.
Sensibilidad Terapéutica	Altamente sensible a programas de Reestructuración Cognitiva TCC y Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC), documentando incrementos en Reevaluación y caídas en Catastrofización.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada reactivo se califica de 1 a 5 (1 = «(Casi) nunca», 2 = «A veces», 3 = «Regularmente», 4 = «A menudo», 5 = «(Casi) siempre»). No contiene reactivos invertidos:

- **Puntuación por Estrategia (9 subescalas):** Se suman los 4 ítems correspondientes a cada dimensión (Rango por subescala: **4 a 20 puntos**).
- **Macro-Puntuaciones Secundarias:**
 - *Afrontamiento Cognitivo Adaptativo:* Suma de Aceptación + Foc. Positiva + Replanificación + Reevaluación + Perspectiva (Rango: **20 a 100 puntos**).
 - *Afrontamiento Cognitivo Desadaptativo:* Suma de Autoculpa + Rumiación + Catastrofización + Culpar a otros (Rango: **16 a 80 puntos**).

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PUNTOS DE CORTE (RANGOS POR SUBESCALA)

Nivel de Uso	Puntuación Sub.	Perfil de Pensamiento	Significación Clínica y Asistencial
Bajo	4 a 9 puntos	Uso escaso de la estrategia	Si es adaptativa: déficit cognitivo para procesar el estresor. Si es desadaptativa: protección.
Medio / Típico	10 a 13 puntos	Uso moderado intermitente	Frecuencia poblacional normal; activación contingente ante situaciones específicas.
Alto / Crónico	14 a 20 puntos	Estrategia rectora predominante	Si es adaptativa (≥ 14): recurso resiliente. Si es desadaptativa (≥ 14 en Catastrofización o Rumiación): foco patológico prioritario.

ALERTA CLÍNICA: CATASTROFIZACIÓN ≥ 14 PUNTOS:

Una puntuación en **Catastrofización ≥ 14 puntos** cuadruplica el riesgo de somatización crónica y amplifica la intensidad del dolor en pacientes con patología orgánica. El pensamiento de que «esto es lo peor que podría pasar» desactiva el córtex prefrontal e hiperactiva las vías espinales descendentes de facilitación del dolor.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN REGULACIÓN COGNITIVA

GUÍA DE INTERVENCIÓN TCC BASADA EN EL PERFIL CERQ:

- **Paso 1: Desactivar Estrategias Tóxicas (Autoculpa, Rumiación, Catastrofización ≥ 14):** Desafío de pensamientos distorsionados, reestructuración socrática de catastrofismo y experimentos de descentramiento cognitivo.
- **Paso 2: Entrenar Estrategias Adaptativas Faltantes (Reevaluación o Planes ≤ 10):** Si Reevaluación es baja, entrenar técnicas de reframing ("¿Qué oportunidad de aprendizaje se abre aquí?"). Si Replanificación es baja, modelar resolución de problemas por pasos (D'Zurilla & Goldfried).
- **Paso 3: Monitorización Basada en Medición:** Reevaluación a las 8 semanas; un incremento en la ratio Adaptativo/Desadaptativo es el mediador primario de la recuperación en TCC.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN CRISIS DE ANSIEDAD TRAS RUPTURA

Paciente: Varón de 31 años, analista de sistemas, acude tras ruptura de pareja no anticipada hace un mes. Presenta ataques de pánico nocturnos, náuseas e incapacidad para concentrarse en su trabajo.

Perfil CERQ en Línea Base (Rango 4 a 20 por subescala):

• **Estrategias Desadaptativas:** Catastrofización = **19 / 20 puntos** (ítem 8 = 5: «Pienso continuamente en lo terrible que es todo»); Rumiación = **18 / 20**; Autoculpabilización = **17 / 20** (ítem 1 = 5: «Siento que toda la culpa ha sido mía»).

• **Estrategias Adaptativas:** Reevaluación Positiva = **5 / 20 puntos**; Replanificación = **6 / 20**; Poner en Perspectiva = **5 / 20**.

Formulación Clínica: El paciente sufre un secuestro cognitivo desadaptativo. Mantiene el dolor emocional vivo mediante pensamientos de culpa total y anticipación de soledad catastrófica irreversible.

Tratamiento TCC y Evolución: En 12 sesiones se aplicó reestructuración de la culpa desmedida y entrenamiento en Reevaluación y Perspectiva. Al cierre: Catastrofización descendió a **7**, Autoculpa a **6**, y Reevaluación Positiva subió a **16**. Remisión total del pánico nocturno y reintegración a su vida social.

9. ALERTAS CLÍNICAS Y GESTIÓN DE PROCESOS

ALERTA: AUTOCULPABILIZACIÓN + CATASTROFIZACIÓN

La presencia simultánea de puntuaciones ≥ 16 en Autoculpa y Catastrofización correlaciona con ideación de suicidio activa. El paciente se percibe como la causa del daño y juzga el futuro como intolerable y sin escape.

DISTINCIÓN ENTRE FOCALIZACIÓN POSITIVA Y NEGACIÓN

Puntajes altos en Focalización Positiva no siempre son saludables si se usan como una evitación experiencial cognitiva para no procesar pérdidas graves que requieren duelo activo.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. *Personality and Individual Differences*, 30(8), 1311–1327.
2. Domínguez-Sánchez, F. J., Lasa-Aristu, A., Amor, P. J., & Holgado-Tello, F. P. (2011). Psychometric properties of the Spanish version of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. *Assessment*, 18(1), 89–98.
3. Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Cognitive emotion regulation questionnaire—development of a short 18-item version (CERQ-short). *Personality and Individual Differences*, 41(6), 1045–1053.
4. Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2010). Specificity of cognitive emotion regulation strategies: a transdiagnostic examination. *Behaviour Research and Therapy*, 48(10), 974–983.